HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

«ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ»

КОНСПЕКТ УРОКА

Вступительный урок

чувствительное пищеварение

О чём этот урок

Вводный урок к **протоколу по чувствительному пищеварению**. По результатам диагностического теста у вас определён **чувствительный тип**. Разбираем, что за ним стоит, какие состояния с ним связаны, какие обследования можно пройти и как будет строиться работа на программе.

Чувствительное пищеварение — не диагноз, а собирательный термин: **повышенная реактивность ЖКТ** на раздражители — пищу, напитки и т. д. Обычные люди переносят их спокойно, а гиперчувствительный ЖКТ отвечает целым спектром неприятных симптомов.

1. Как проявляется чувствительное пищеварение

Желудок и пищевод

✔️ слабые тянущие или ноющие боли в животе натощак — не острые, иногда на грани дискомфорта

✔️ изжога, слабое жжение в пищеводе, горечь во рту

✔️ чувствительность к температуре: дискомфортно глотать что-то со льдом или горячее

✔️ тошнота от голода или стресса — при волнении подташнивает, вплоть до пустой рвоты

✔️ покраснение языка, налёт, трещины на языке

Кишечник

✔️ вздутие после еды, особенно вечером, во второй половине дня

✔️ метеоризм, газы от клетчатки: яблоки, зелень, капустные, фрукты со шкуркой, много фруктов

✔️ запоры, диарея или их чередование

✔️ слизь в стуле

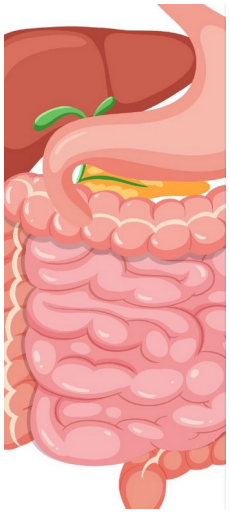
✔️ ощущение неполного опорожнения кишечника

Все жалобы «в полном боекомплекте» не обязательны — здесь собраны самые характерные.

2. Какие состояния стоят за жалобами

Состояние	Что это
Повышенная висцеральная чувствительность	«Висцеральная» — относящаяся к животу. ЖКТ слишком остро реагирует на раздражители: механическое растяжение пищевым комком (обычный кишечник просто продвигает его, а гиперчувствительный ощущает перистальтическую волну как боль), органические кислоты, кислый вкус, холодную пищу. Даже обычная еда вызывает боли, спазмы, вздутие

Состояние	Что это
Рефлюкс, гиперчувствительный пищевод	Заброс содержимого желудка в пищевод. Слизистая пищевода и желудка истончена и слишком ярко реагирует на температуру и кислоты — отсюда изжога
Нарушение желчеоттока	«Фирменный» диагноз чувствительного пищеварения — дискинезия желчевыводящих путей
Ферментативная недостаточность тонкой кишки	Недостаточно ферментов для финального переваривания белков, жиров и углеводов → непереносимости: лактозы, глютена. Непереносимость глютена может накопиться с возрастом без целиакии в детстве — нецелиакийная чувствительность к глютену
Дисбиоз	ЖКТ работает неоптимально → развивается патогенная микрофлора → брожение клетчатки и сахаров, вздутие, метеоризм, слизь в стуле
Субклиническое воспаление кишечника	Слабое воспаление, которое не видно ярко по анализам, — синдром повышенной кишечной проницаемости. В научной литературе считается стартовой точкой аутоиммунных заболеваний, аллергических реакций и др.



Другие характерные состояния

Состояние	Пояснение
Тревожные расстройства	От повышенного нервного напряжения и высокой чувствительности к стрессу до панических атак

Состояние	Пояснение
Синдром хронической усталости, астения	Связан с дефицитом питательных веществ
Анемия, дефициты белка, витаминов группы В, жирорастворимых витаминов	Синтез ферментов снижен — хуже усваиваются аминокислоты, жиро- и водорастворимые витамины, микроэлементы
Сухость и истончение кожи, себорея, дерматиты, нейродермит	Следствие дефицитов
Хронические инфекции: герпес, кандидоз и др.	Иммунитету не хватает питательных веществ, чтобы эффективно подавлять инфекции
Неровный менструальный цикл, выраженный ПМС, ранняя менопауза	Наблюдение из практики — у женщин с чувствительным типом
Аутоиммунные заболевания	Со временем — в связи с синдромом повышенной кишечной проницаемости

> Не обязательно, что у вас есть весь список, — хорошо, если ничего или что-то одно. Но эти состояния часто встречаются в практике и служат косвенными маркерами склонности к чувствительному типу.

3. Какие обследования можно пройти

Для программы это **необязательный шаг**: по диагностическому тесту всё понятно, и протокол питания, специи и травы уже подобраны под ваши жалобы. Но чтобы до конца разобраться, что происходит, обследоваться полезно — **раз в год-два**.

Зачем обследоваться: провести водораздел — **есть воспаление или нет**. Жалобы при чувствительном типе могут сильно беспокоить и пугать, особенно при повышенной тревожности. Важно понять, далеко ли зашла проблема или она в зачаточной стадии.

Важно: точный список анализов для вашего случая назначает **врач-гастроэнтеролог**, он же интерпретирует результаты в комплексе — по одному анализу выводы не делаются.

Что может быть выявлено

Многие состояния при чувствительном типе — **функциональные нарушения**: структура органа не изменена, воспаления нет, слизистая не нарушена, а жалобы есть.

Функциональные

✔️ синдром раздражённого кишечника (СРК) — вздутие, метеоризм, слизь, ощущение неполного опорожнения, нарушения стула без воспаления

✔️ ГЭРБ, рефлюкс, функциональная изжога

✔️ дискинезия желчевыводящих путей

✔️ диспепсия

Органические и другие

✔️ хронический гастрит — воспаление слизистой

✔️ загиб жёлчного пузыря и жёлчный сладж (густая желчь — риск камней)

✔️ пищевые непереносимости: лактоза, фруктоза, глютен и др.

> **История из практики:** девушка с большим списком жалоб чувствительного типа прошла обширное обследование — воспаления не нашлось, но клиника была неприятной. Это очень характерная ситуация для чувствительного пищеварения.

Список обследований

Обследование	Что показывает
УЗИ органов брюшной полости + УЗИ жёлчного под нагрузкой	Печень, жёлчный, поджелудочная: полипы, сладж, камни, структура пузыря, паренхима поджелудочной. Под нагрузкой — есть ли дискинезия и какого типа. Входит в ежегодную диспансеризацию
Общий анализ крови, ферритин, B12, фолиевая кислота (по желанию)	Дефицит железа и кофакторов
Общий белок, альбумин	Усвоение белка
АЛТ, АСТ, билирубин общий и прямой	Функции печени и желчевыводящих путей
СРБ ультрачувствительный, СОЭ	Косвенная оценка уровня воспаления

Обследование	Что показывает
Копрограмма	Совокупная оценка всех отделов ЖКТ. Хороший стартовый анализ, но не показывает, в каком отделе нарушение: непереваренный белок может быть проблемой желудка, поджелудочной, желчи или кишечника
Кал на скрытую кровь и кальпротектин	Маркеры воспаления в кишечнике — без колоноскопии. При отклонениях врач направит на колоноскопию. Кальпротектин показывает воспаление и в тонкой, и в толстой кишке, а колоноскопия — только толстую
ФГДС с биопсией	Структура желудка и пищевода, клапаны, воспаление, H. pylori, клетки слизистой. Входит в протоколы обследования после 45 лет раз в 2–3 года — элемент ранней диагностики
Кровь на «Гастропанель»	Неинвазивный старт, если страшно делать ФГДС: состояние слизистой, воспаление, кислотность, H. pylori (антитела — текущая или перенесённая инфекция)
24-часовая pH-метрия	Зонд на сутки: интенсивность и частота рефлюкса при выраженной ГЭРБ, кислотность
Водородно-дыхательный тест	СИБР — если вздувает «на всё подряд», не только вечером, и на пробиотики, кисломолочное, квашеную капусту, комбучу. Также непереносимость лактозы, фруктозы, других сахаров

4. Цель программы

Восстановить нормальную активность ЖКТ, снизить гиперчувствительность и не допустить развития воспаления.

Воспаления как такового может ещё не быть, но чувствительный тип — шаг в ту сторону, поэтому важна **профилактика**. С помощью питания, образа жизни, трав, специй, нутрицевтиков мы будем:

- восстанавливать слизистые;
- снижать гиперреактивность ЖКТ;

- стабилизировать работу нервной системы;
- мягко и бережно восстанавливать моторику ЖКТ и желчевыделение;
- улучшать переваривание пищи и усвоение питательных веществ;
- повышать качество жизни, общее состояние и энергию.

Как мы будем работать (5 недель)

1. **Подготовка ЖКТ** мягкими природными сорбентами.
2. **Успокаивающие чаи** и первые рецепты в рационе.
3. **Налаживание режима дня.**
4. **Регуляция нервной системы**, снижение хронического стресса.
5. **Коррекция питания**: убрать то, что мешает пищеварению, добавить мягкие продукты и специи — стимуляторы ЖКТ.
6. **Полноценное разнообразное меню**, которое хорошо переваривается и закрывает дефициты.
7. **Специи, травы, фитосоставы.**
8. **Домашние процедуры**: гимнастика, техники из йоги и йогатерапии для нервной системы и ЖКТ.

Темп — спокойный: двигаемся пошагово, плавно, без резких движений. При чувствительном пищеварении тревожности и так достаточно — интенсивный темп её только усилил бы.

Задание на первую неделю: посмотрите другие уроки недели — списки трав и специй, рецепты напитков, фитосоставов и первых блюд. Подготовьте всё необходимое: со следующей недели начнём использовать.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое чувствительное пищеварение? Это диагноз?
2. Какие жалобы характерны для чувствительного типа со стороны желудка и пищевода? А со стороны кишечника?
3. Что такое повышенная висцеральная чувствительность? Приведите пример.
4. Почему при чувствительном типе возникает изжога и чувствительность к температуре еды?
5. Какой диагноз называют «фирменным» для чувствительного пищеварения?
6. Как ферментативная недостаточность тонкой кишки связана с пищевыми непереносимостями? Что такое нецелиакийная чувствительность к глютену?
7. Что такое синдром повышенной кишечной проницаемости и почему он важен?
8. Какие состояния вне ЖКТ часто сопровождают чувствительный тип и почему?
9. Зачем при чувствительном типе обследоваться, если для программы это необязательно?

10. Что такое функциональные нарушения? Приведите примеры.
11. Какие органические изменения могут выявить при обследовании?
12. Что показывают УЗИ, УЗИ жёлчного под нагрузкой и анализы крови?
13. Почему копрограмма — хороший стартовый, но недостаточно точный анализ?
14. Чем анализ кала на кальпротектин отличается от колоноскопии?
15. С какого анализа можно начать, если страшно делать ФГДС?
16. Когда стоит сделать водородно-дыхательный тест?
17. Какие цели у программы при чувствительном типе и почему темп работы будет спокойным?